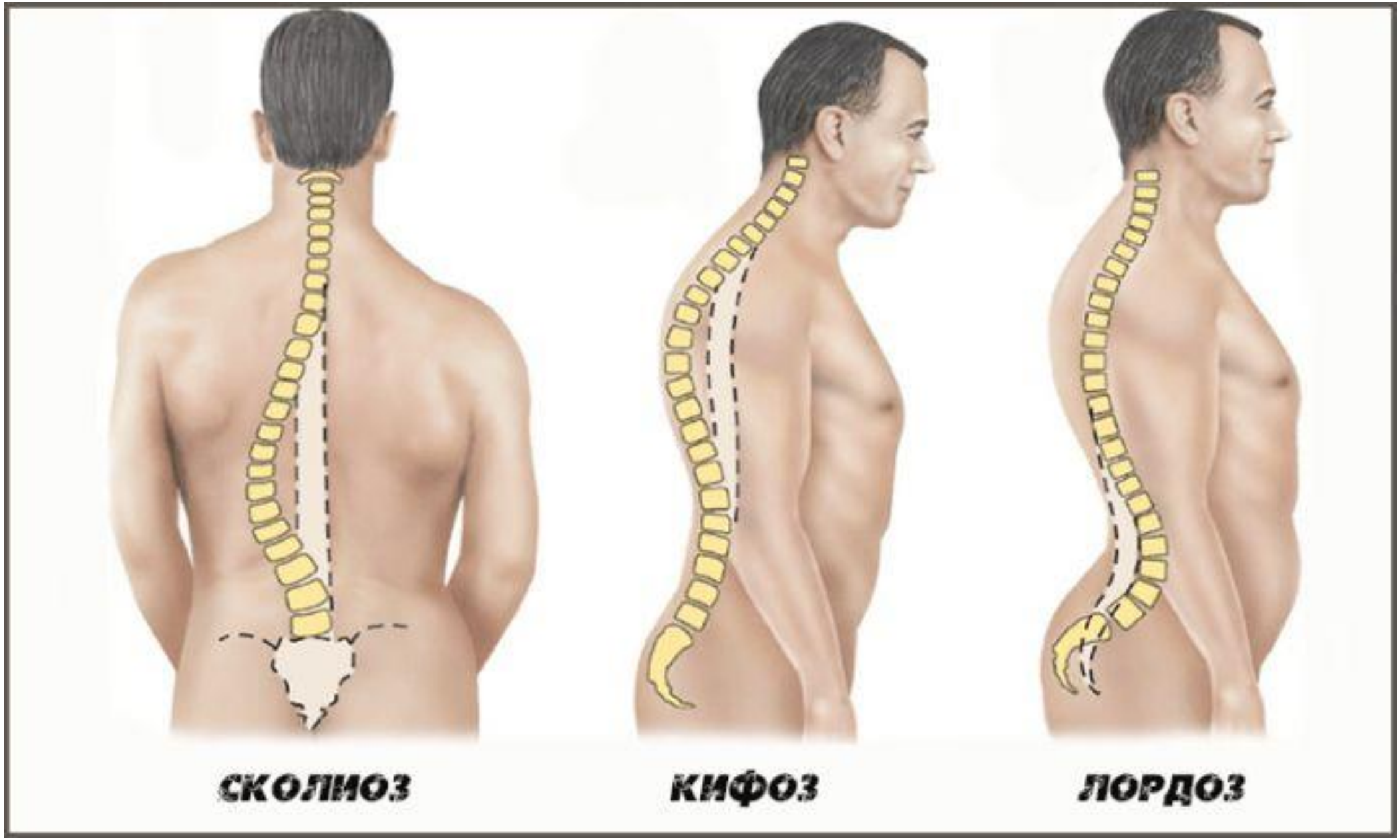
Заболевания опорно- двигательной системы


СКОЛИОЗ
КИФОЗ
ЛОРДОЗ

Сколиоз — это сложное заболевание костно-мышечной системы, характеризующееся стойким боковым искривлением позвоночника.

Патология развивается в детском и подростковом возрасте. Признаки болезни могут появиться и у взрослых. Чаще возникает в период интенсивного роста: с 4 до 6 и с 10 до 14 лет. В особом наблюдении нуждаются дети на этапе полового созревания: для девочек это с 10 до 13 лет, для мальчиков с 11 до 14 лет.

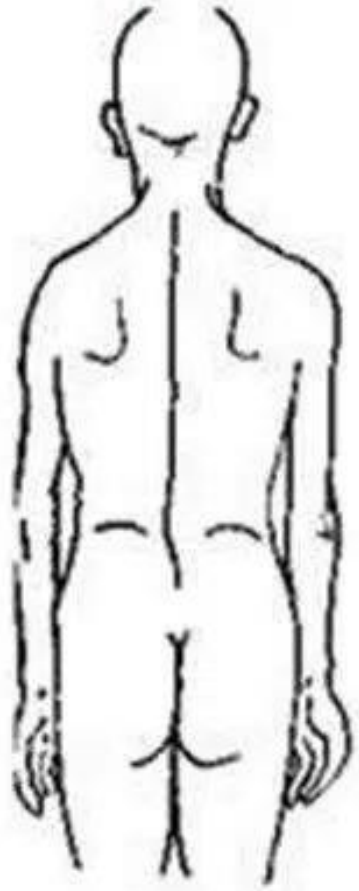
Искривление может возникнуть в шейном, грудном или поясничном отделах.

Формы искривления подразделяют на несколько типов:
* С-образный. деформация позвоночника с одним боковым изгибом. Чаще расположен в грудном отделе.
* S-образный. С двумя боковыми изгибами.
* Z-образный. Крайне редкая форма, с тремя изгибами.

Общие причины возникновения сколиоза
* Идиопатические. Неустановленная этиология (причины возникновения не определены).
* Вторичные. Последствия травм, переломов, операций; при ограничении движений в суставах.
* Врожденные. Аномалии развития позвоночника.
* Нейромышечные. На фоне рассеянного склероза, ДЦП, хронических заболеваний центральной нервной системы, слабость мышечного аппарата.
* Дисплатические. Генетическая предрасположенность.

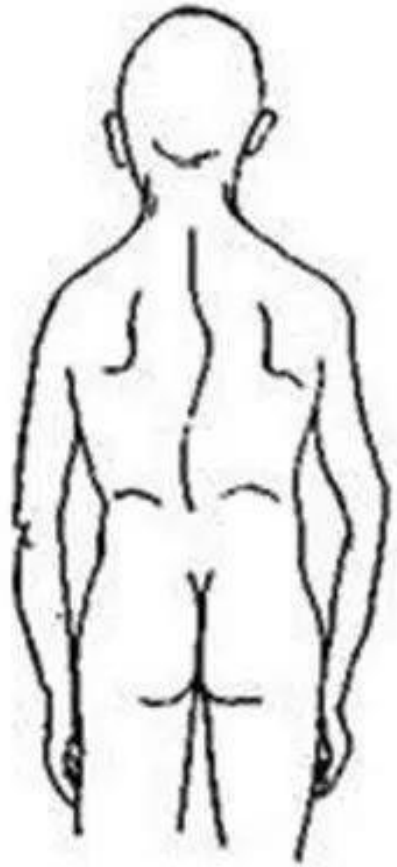
Симптомы сколиоза включают видимую асимметрию тела: одно плечо или лопатка выше другого, неровная талия, выпирание одного бедра или ребер (реберный горб). При наклоне вперед искривление позвоночника становится наиболее заметным. Также наблюдаются боли в спине/шее, утомляемость, ограничение подвижности

I



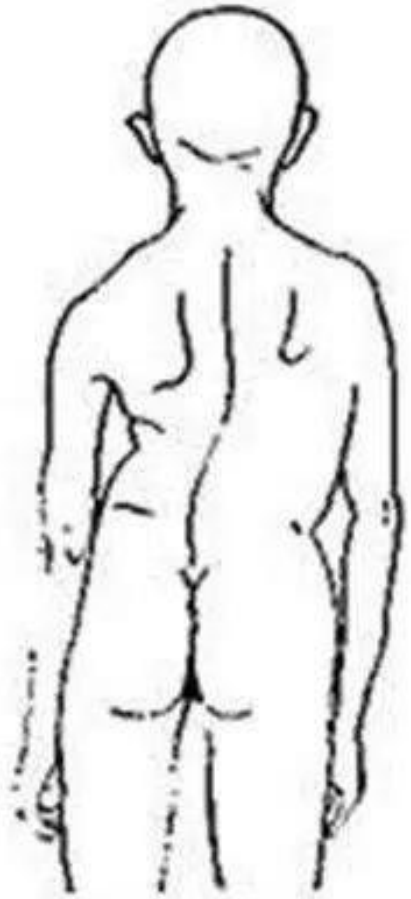
I степень – от 1 до10 градусов (170^0)

II



II степень – от 11 до 25 градусов (155^0)

III

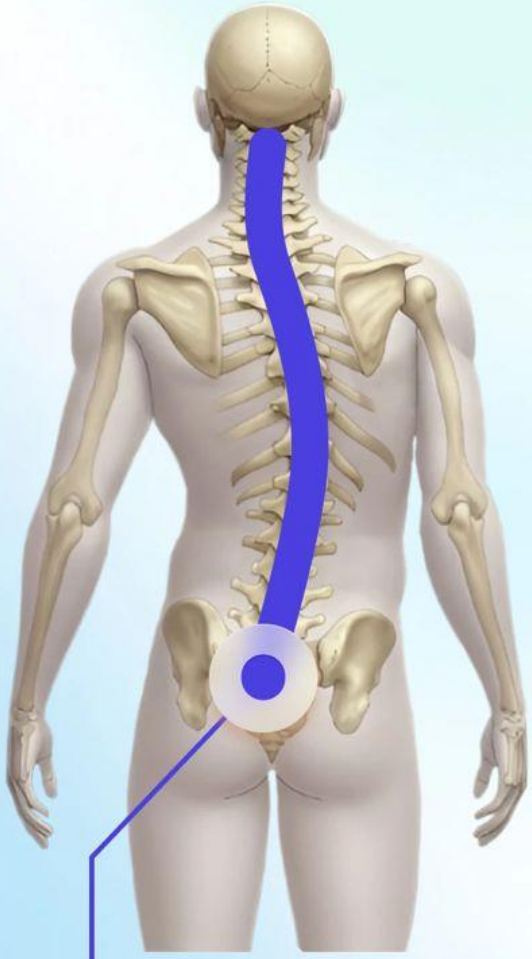


III степень – от 26 до 50градусов (140^0)

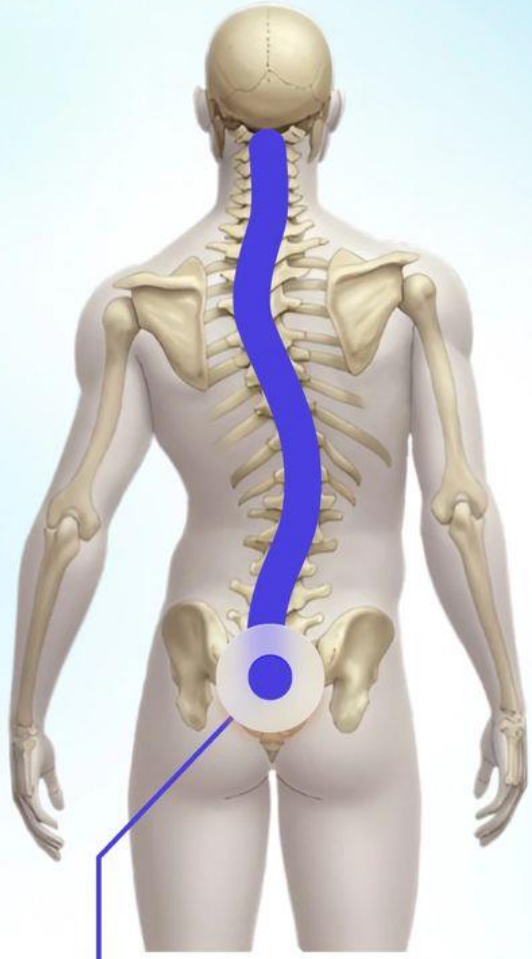
IV



IV степень – более 50 градусов



C-образный



S-образный



Z-образный

В норме человеческий позвоночник имеет 4 искривления: два лордоза (поясничный и шейный) и два кифоза (крестцовый и грудной). Все они расположены в переднезаднем (саггитальном) направлении. Боковых искривлений (сколиоза) в норме быть не должно.

Лордоз – это физиологический или патологический изгиб позвоночника, при котором его выпуклость обращена кпереди. Физиологический лордоз наблюдается у всех людей в поясничном и шейном отделе позвоночника. Патологический лордоз обычно располагается в этих же отделах, но отличается от физиологического степенью изгиба.

Причины:

Слабость мышц спины, рахит, ДЦП, плохая осанка, избыточный вес, беременность, дисплазия тазобедренных суставов, травмы позвонков, остеопороз, воспалительные процессы.

Основные симптомы (патологический лордоз):

* Выраженный изгиб, "вываливающийся" живот, выпирающие ягодицы (поясничный лордоз).
* Голова и плечи выдвинуты вперед, "крыловидные" лопатки (шейный лордоз).
* Постоянное напряжение и боли в пояснице или шее.
* Ограничение подвижности, боли при наклонах.
* Возможно онемение, "мурашки" в конечностях



Лордоз

Кифоз – это искривление позвоночника в передне- заднем направлении . Может быть как физиологическим (нормальным), так и патологическим. Патологический кифоз чаще развивается в грудном отделе, нередко сопровождается болями в спине. При значительном искривлении возможно сдавление нервных корешков и спинного мозга с соответствующей симптоматикой (слабость в ногах, нарушения чувствительности, тазовые расстройства). В особенно тяжелых случаях может наблюдаться нарушение деятельности сердца и легких.

Патология может возникнуть вследствие нарушений внутриутробного развития, неблагоприятной наследственности, травм и операций на позвоночнике, слабости мышц спины при недостаточных физических нагрузках и т. д. У пожилых людей (особенно – женщин) кифоз часто развивается вследствие патологических компрессионных переломов грудных позвонков. Причиной таких переломов становится остеопороз – уменьшение плотности костей. Кроме того, кифоз может формироваться при некоторых инфекционных и неинфекционных заболеваниях: спондилите, анкилозирующем спондилите (болезни Бехтерева) и опухолях позвоночника.

Симптомы: сутулость, «круглая спина», часто — выраженный горб. Плечи сведены вперед и опущены, лопатки выступают; боль в грудном или поясничном отделе, усиливающаяся при длительном стоянии или сидении. Часто возникает напряжение мышц; голова наклонена вперед, ограничение подвижности позвоночника. Одышка, затрудненное дыхание из-за сдавления грудной клетки, ощущение нехватки воздуха. Онемение, слабость в ногах или руках.